DRA. DUNIA VERONA
cirurgia plástica
CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527 · MEMBRO DA SBCP

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Reconstrução de mama

Identificação

Paciente (nome civil):

Nome social, se houver:

Data de nascimento: CPF:

RG: Estado civil e profissão:

Endereço:

Celular: E-mail:

Procedimento: Reconstrução de mama

Área(s) a ser(em) tratada(s):

Local do procedimento:

Data prevista:

Médica responsável: Dra. Dunia Verona · Cirurgiã plástica · CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527 · Membro da SBCP

Responsável legal (se paciente menor de idade ou incapaz):

_____

Por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, paciente identificado(a) acima, declaro que, em consulta realizada em ____/____/_____ com a Dra. Dunia Verona, cirurgiã plástica (CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527), recebi informações verbais e por escrito sobre o procedimento de RECONSTRUÇÃO DE MAMA, ao qual me submeterei voluntariamente. As informações foram dadas em linguagem clara e acessível, tive tempo para refletir e todas as minhas dúvidas foram respondidas, em conformidade com os artigos 22, 24, 31 e 34 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), com a Recomendação CFM nº 1/2016 e com o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Declaro estar ciente dos benefícios esperados, das alternativas, dos riscos e das possíveis complicações, conforme descrito a seguir.

1. Da natureza do procedimento e da obrigação assumida

Todo procedimento médico tem, ao mesmo tempo, efeitos sobre a forma e sobre a saúde, entendida como o conjunto de bem-estar físico, mental e social.

A Dra. Dunia Verona se compromete a indicar o procedimento apenas quando adequado ao meu caso e a empregar a técnica adequada, com diligência, prudência e de acordo com o conhecimento científico atual. Fui informado(a) de que o resultado depende também de fatores biológicos individuais, que fogem ao controle da médica (como cicatrização, qualidade da pele, resposta do organismo ao produto ou à cirurgia), e da minha adesão às orientações antes e depois do procedimento.

Não me foi prometido nem garantido um resultado específico. Fotografias de outros pacientes, simulações ou imagens de referência eventualmente mostradas na consulta têm caráter apenas ilustrativo e não representam promessa de resultado.

2. Do procedimento

A reconstrução de mama recria o volume e a forma da mama após a retirada total (mastectomia) ou parcial do tecido mamário, em geral por tratamento de câncer. Pode ser feita no mesmo tempo da mastectomia (imediata) ou depois (tardia).

No meu caso, o planejamento inclui (marcado pela médica):

( ) Reconstrução imediata.

( ) Reconstrução tardia.

( ) Implante de silicone.

( ) Expansor de tecidos, a ser trocado depois por implante.

( ) Retalho das costas (músculo grande dorsal).

( ) Retalho do abdome (TRAM ou DIEP).

( ) Enxerto de gordura (lipoenxertia).

( ) Reconstrução da aréola e do mamilo.

( ) Cirurgia na outra mama para melhorar a simetria.

( ) Outro: _____

A reconstrução é planejada em conjunto com a equipe de mastologia e oncologia. Em geral, são necessárias várias etapas cirúrgicas até o resultado final.

3. Dos benefícios esperados e dos limites

A reconstrução busca devolver o volume e a forma da mama. A mama reconstruída não terá a mesma sensibilidade, textura e movimento da mama natural, e a simetria perfeita com a outra mama

não é possível. A radioterapia, antes ou depois da reconstrução, aumenta o risco de complicações e pode comprometer o resultado.

O tratamento e o acompanhamento do câncer continuam com a equipe oncológica. A reconstrução pode exigir técnicas específicas nos exames de imagem de controle.

4. Das alternativas

Foram-me apresentadas as alternativas, inclusive a de não reconstruir a mama, o uso de próteses externas e as diferentes técnicas de reconstrução.

5. Da anestesia

A anestesia será realizada por médico anestesiologista, que avaliará meu caso na consulta pré-anestésica, definirá o tipo de anestesia mais seguro para mim e me explicará seus riscos, em termo próprio. Comprometo-me a comparecer à avaliação pré-anestésica e a seguir as orientações de jejum que receber.

Tipo de anestesia previsto e local da cirurgia (hospital ou clínica):

6. Dos principais riscos

Como em qualquer cirurgia, foram-me explicados os seguintes riscos gerais:

- Dor no pós-operatório, em geral controlada com medicação.
- Inchaço (edema) e manchas roxas (equimoses), que regridem em algumas semanas; um inchaço residual pode durar meses.
- Hematoma (acúmulo de sangue) ou seroma (acúmulo de líquido), que podem exigir punção, drenagem ou nova cirurgia.
- Infecção, tratada com antibióticos e, raramente, com drenagem ou nova cirurgia.
- Problemas de cicatrização: abertura dos pontos (deiscência), cicatrizes alargadas, elevadas (hipertróficas) ou queloides. A qualidade da cicatriz depende em grande parte de fatores individuais.
- Sofrimento ou necrose (morte) de pele ou de gordura, com risco muito maior em tabagistas, diabéticos e pessoas com problemas circulatórios.

- Alterações de sensibilidade (dormência, formigamento ou sensibilidade aumentada) na região operada, em geral temporárias e, raramente, permanentes.
- Assimetrias: nenhum corpo é simétrico antes da cirurgia, e pequenas diferenças podem persistir ou surgir depois dela.
- Trombose venosa profunda e embolia pulmonar: complicações raras e graves, que podem levar à morte. O risco é avaliado antes da cirurgia e são adotadas medidas de prevenção.
- Reações alérgicas a medicamentos, antissépticos, curativos ou fios.
- Riscos relacionados à anestesia, que serão explicados pelo médico anestesiologista.
- Necessidade de transfusão de sangue em caso de sangramento importante, realizada apenas quando estritamente necessária.
- Resultado diferente do que eu esperava e necessidade de retoque ou de nova cirurgia.
- Embora raras, complicações graves podem levar à morte.

Riscos próprios da reconstrução de mama:

- Sofrimento ou necrose da pele que restou após a mastectomia.
- Perda parcial ou total do retalho, quando usado, exigindo nova cirurgia.
- Complicações na área doadora do retalho: cicatriz nas costas ou no abdome, seroma, diminuição de força no ombro (grande dorsal) ou enfraquecimento e hérnia da parede abdominal (retalhos do abdome).
- Exposição ou extrusão do expansor ou do implante, que pode exigir sua retirada.
- Desconforto durante as sessões de expansão e falha da válvula do expansor.
- Ausência ou diminuição permanente da sensibilidade da mama reconstruída.
- Necessidade de cirurgias adicionais para ajustes e simetria.

Riscos e cuidados próprios dos implantes mamários:

- Contratura capsular: endurecimento do tecido que o corpo forma ao redor do implante, que pode causar dor, endurecimento e deformidade e exigir nova cirurgia.
- Ruptura ou vazamento do implante, que pode não causar sintomas (ruptura silenciosa).
- Ondulações visíveis ou palpáveis (rippling), mau posicionamento, rotação ou deslocamento do implante.

- Seroma tardio (acúmulo de líquido meses ou anos depois) e infecção, que pode exigir a retirada do implante.
- Linfoma anaplásico de grandes células associado ao implante mamário (BIA-ALCL): tipo raro de câncer do sistema imunológico, associado principalmente a implantes de superfície texturizada, que costuma se manifestar com aumento de volume tardio da mama. Tem tratamento, em geral com retirada do implante e da cápsula.
- Relatos raríssimos de outros tumores relacionados à cápsula do implante.
- Sintomas gerais que algumas pacientes atribuem aos implantes (como cansaço, dores articulares e dificuldade de concentração), cuja relação com os implantes ainda está em estudo.
- Implantes não são dispositivos vitalícios: ao longo da vida pode ser necessário trocá-los ou retirá-los, em nova cirurgia, com custos próprios.
- Devo fazer acompanhamento periódico das mamas com exames de imagem (ultrassonografia ou ressonância magnética), conforme orientação médica, e informar que tenho implantes ao fazer mamografia.

7. Das pessoas com maior risco

- Pacientes que fizeram ou farão radioterapia ou quimioterapia.
- Tabagistas, diabéticas, pessoas com obesidade e com problemas de coagulação.

8. Dos cuidados antes da cirurgia

- Parar de fumar, inclusive cigarro eletrônico e narguilé, por pelo menos 60 (sessenta) dias antes e durante toda a recuperação. A nicotina prejudica a circulação e aumenta muito o risco de necrose e de problemas de cicatrização. Parar de fumar diminui, mas não elimina, os efeitos do uso anterior; o mesmo vale para álcool e outras drogas.
- Informar todos os medicamentos, suplementos e chás que uso. Alguns precisam ser suspensos antes da cirurgia (como AAS, anti-inflamatórios, anticoagulantes, alguns hormônios, ômega 3, vitamina E e ginkgo biloba), mas só devo suspendê-los com orientação médica.
- Realizar os exames e as avaliações solicitados, inclusive a avaliação cardiológica quando indicada.
- Comunicar até 2 (dois) dias antes qualquer gripe, febre, infecção, ferida na pele ou mudança no meu estado de saúde.
- Seguir o jejum orientado pela anestesia e comparecer no horário marcado.

- Ter um acompanhante adulto para a alta e para as primeiras 24 (vinte e quatro) horas, e não dirigir nesse período.

Período previsto de afastamento do trabalho e das atividades habituais:

9. Dos cuidados depois da cirurgia

- Fazer repouso relativo, caminhando dentro de casa desde o primeiro dia, para ajudar a prevenir trombose.
- Tomar os medicamentos nos horários prescritos e cuidar dos curativos conforme orientado.
- Usar o sutiã ou a faixa orientados, dormir de barriga para cima e evitar esforço com os braços pelo tempo orientado.
- Cuidar dos drenos até sua retirada e comparecer às sessões de expansão, quando houver.
- Evitar esforço físico e atividade física até a liberação médica.
- Proteger as cicatrizes do sol por pelo menos 6 (seis) meses e usar protetor solar quando liberado.
- Não fumar durante a recuperação.
- Comparecer a todos os retornos marcados.
- Evitar contato direto com cães e gatos nos primeiros 20 (vinte) dias e não deixá-los subir na cama, pelo risco de infecção.

Devo avisar a médica imediatamente se tiver febre acima de 38 °C, dor que piora mesmo com o remédio, sangramento que não para, inchaço forte e súbito de um lado só, secreção com mau cheiro, falta de ar, dor no peito ou dor e inchaço na panturrilha.

10. Do resultado

O resultado se constrói ao longo das etapas, em geral em vários meses. As cicatrizes amadurecem em 1 (um) ano a 1 (um) ano e meio.

A cicatriz passa por três fases: até o 30º dia costuma ter bom aspecto; do 30º dia ao 12º mês fica naturalmente mais espessa e muda de cor (do vermelho ao marrom, depois clareia), fase que mais preocupa as pacientes mas é temporária; do 12º ao 18º mês fica mais clara e fina até o aspecto

definitivo. Por isso, a avaliação definitiva da cicatriz só pode ser feita após cerca de 18 (dezoito) meses.

Cerca de 6 (seis) meses após a cirurgia, farei uma consulta com novas fotos para avaliar o resultado. Se necessário, poderão ser sugeridos pequenos retoques ou refinamentos, em data combinada com a médica. Retoques fazem parte da cirurgia plástica e não significam, por si, falha no procedimento.

11. Do implante

Fui informada sobre o implante que será utilizado. Seus dados serão registrados no prontuário e receberei o cartão de identificação do implante, com fabricante, modelo, lote e registro na Anvisa, que devo guardar.

	FABRICANTE E MODELO	SUPERFÍCIE E VOLUME	LOTE	REGISTRO ANVISA
Mama direita				
Mama esquerda				

12. Das declarações e consentimentos

- **FUI INFORMADO(A),** de modo claro e completo, sobre o procedimento, seus benefícios esperados, as alternativas disponíveis (inclusive a de não realizar o tratamento), as consequências de não realizá-lo, os riscos, as possíveis complicações e o período de recuperação. Pude fazer perguntas e recebi respostas que julguei suficientes.
- **RECEBI** ESTE TERMO com antecedência, em _____/_____/_____, e tive tempo para lê-lo com calma, conversar com pessoas de minha confiança e, se quisesse, buscar uma segunda opinião antes de assiná-lo.
- **EXPUS** À MÉDICA o que espero do procedimento. Ela me explicou o que é possível alcançar no meu caso, quais são os limites e o que não é possível alcançar.

Minha queixa e o que espero do procedimento:

Riscos ou cuidados específicos do meu caso, discutidos na consulta:

- **AFIRMO** ter feito um relato cuidadoso e verdadeiro da minha história pessoal e familiar de saúde física e mental, incluindo alergias, doenças, cirurgias e procedimentos anteriores, sangramentos e reações a medicamentos ou anestésicos. Entendo que omitir informações pode resultar em complicações importantes.
- **COMPROMETO-ME** a informar todo e qualquer medicamento, suplemento, fitoterápico ou outra substância, lícita ou ilícita, utilizados nos 7 (sete) dias anteriores ao procedimento, além do consumo de álcool.
- **DECLARO** que não estou grávida nem amamentando e que fui informada dos riscos do procedimento durante a gestação e a amamentação. ( ) Não se aplica.
- **ESTOU** CIENTE de que deixar de prestar informações verdadeiras, não seguir as orientações e prescrições ou abandonar o acompanhamento pode prejudicar o resultado e causar complicações, e que essas condutas poderão ser consideradas como minha contribuição para o resultado (art. 945 do Código Civil e art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor).
- **DECLARO** que nada omiti em relação à minha saúde e autorizo que esta declaração integre meu prontuário, podendo ser utilizada pela médica no exercício regular de seus direitos, inclusive em processo judicial ou administrativo (art. 7º, VI, e art. 11, II, "d", da Lei nº 13.709/2018). Autorizo também que a médica solicite, quando necessário para a minha assistência, cópias de exames e informações de outros serviços de saúde onde eu tenha sido atendido(a).
- **RECONHEÇO** que, durante o procedimento, podem surgir situações novas que não puderam ser identificadas antes. Nesses casos, AUTORIZO a médica e sua equipe a adotar as medidas necessárias para preservar minha saúde e segurança. Procedimentos adicionais com finalidade apenas estética não serão realizados sem meu consentimento prévio.
- **FUI ORIENTADO(A)** sobre os cuidados antes e depois do procedimento, que devo cumprir rigorosamente, e sobre as possíveis intercorrências. Estou ciente de que devo comparecer aos retornos agendados e de que minha ausência será registrada no prontuário e poderá caracterizar abandono do acompanhamento.

- **RECEBI** o contato da equipe para dúvidas e intercorrências: WhatsApp (21) 97440-2673. Em caso de urgência ou emergência, devo procurar o pronto-socorro mais próximo e avisar a médica assim que possível.
- **FUI INFORMADO(A),** por orçamento escrito, sobre os valores do procedimento. Retoques, procedimentos complementares e o tratamento de eventuais intercorrências seguirão as condições descritas nesse orçamento; o que não estiver incluído nele me será informado e orçado previamente.

FOTOGRAFIAS E VÍDEOS

Autorizo que sejam feitas fotografias e vídeos antes, durante e depois do procedimento, para compor meu prontuário e acompanhar minha evolução. Esses registros fazem parte do meu atendimento e são mantidos em sigilo.

Além do prontuário (marque uma ou mais opções):

( ) Autorizo o uso em aulas, congressos e publicações científicas, sem identificação.

( ) Autorizo o uso em materiais de divulgação da médica (site e redes sociais), sem identificação e com finalidade educativa, conforme a Resolução CFM nº 2.336/2023.

( ) Não autorizo nenhum uso além do prontuário.

Minha escolha não interfere no meu atendimento. Posso revogá-la a qualquer momento, por escrito, sem efeito sobre o que já tiver sido publicado antes da revogação.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

A controladora dos meus dados pessoais é a Dra. Dunia Verona (contato: draduniaverona@gmail.com). Meus dados, inclusive os de saúde, são tratados para a minha assistência e para o cumprimento de obrigações legais e regulatórias (art. 7º, II, e art. 11, II, "a" e "f", da Lei nº 13.709/2018). Eles só serão compartilhados com quem participa do meu cuidado (como hospital, laboratório, equipe de anestesia e fornecedores, quando necessário) ou por determinação legal. O prontuário é guardado por, no mínimo, 20 (vinte) anos (Lei nº 13.787/2018). Posso solicitar acesso, correção e informações sobre o uso dos meus dados pelo e-mail acima (art. 18 da LGPD).

REVOGAÇÃO E ASSINATURA

- **FUI INFORMADO(A)** de que posso revogar meu consentimento a qualquer momento antes do início do procedimento, comunicando minha decisão à médica e assinando o Termo de Revogação, que me será entregue quando eu manifestar essa vontade. As condições financeiras da desistência seguem o orçamento.

- **CONFIRMO** que este termo formaliza um processo de informação e esclarecimento iniciado na primeira consulta.
- **LI ESTE** TERMO POR INTEIRO, rubriquei todas as suas páginas e recebi uma via assinada.

O presente Termo é firmado em 2 (duas) vias de igual teor, uma destinada ao(à) paciente e outra à médica.

( ) CONSINTO ( ) RECUSO a realização do procedimento de reconstrução de mama.

Rio de Janeiro – RJ, ____ de _____ de 20____.

_____

Assinatura do(a) paciente

Nome completo:

_____

Responsável legal, se paciente menor de idade ou incapaz

Nome, CPF e parentesco:

_____

Testemunha (opcional)

Nome e CPF:

Declaração da médica

Declaro que informei, expliquei e esclareci todas as dúvidas do(a) paciente sobre o procedimento de reconstrução de mama, seus benefícios, riscos, alternativas e efeitos adversos, e que o(a) paciente, ou seu responsável legal, demonstrou ter compreendido o que foi tratado neste termo. Comprometo-me a prestar assistência de forma diligente, prudente e eficiente.

Rio de Janeiro – RJ, ____ de _____ de 20____.

_____

Dra. Dunia Verona

Cirurgiã plástica · CRM-RJ 52 0126416-8 · RQE 60527